

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalused koduõenduses ja -hoolduses kuue riigi näitel



Piret Tamme

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool



Viivu Tuulik, MD, Ph.D

Koduhooldusega toetame inimesi, kes vajavad argielu korraldamisel pikemalt abi. Mitmed analüüsid on välja toonud, et Eestis on pikaajaline hooldus tervikuna alarahastatud ja ebaefektiivselt korraldatud, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna teenused ei ole omavahel seotud ning neid ei pakuta kõikjal piisavalt (Maailmapank 2017; Paat-Ahi 2017, 17–20).

Eriti suur puudus on teenustest, mille toel saaks eakas inimene võimalikult kaua elada oma kodus. Vanemaealisi on järjest rohkem ning seetõttu kasvab ka nõudlus koduhoolduse jt pikaajaliste hooldusteenuste järele. Eestis on võetud eesmärgiks luua terviklik pikaajalise hoolduse süsteem, mis toimiks inimkeskselt ja kus teenused on võrdväärselt kättesaadavad kõigile (Tarum 2017). Teiste riikide kogemuste põhjal aitab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste läbimõeldum kasutamine hooldussüsteemi tõhustada.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb Interreg projektis Nurse Education Development (NURED), et töötada välja uued õppekavad koduõendele ja -hooldajatele. Seejuures on olulisel kohal

meeskonnatöö ja kutseoskuste arendamine, sh oskus kasutada tänapäevaseid IKT lahendusi.

Õppekavade uuendamise käigus uurisime ka, kui palju ja milliseid IKT lahendusi kasutatakse mujal ja millised on kogemused. Järgnevalt annamegi ülevaate kuue riigi kogemustest ja teeme ettepanekuid, kuidas võiks samu lahendusi kasutada Eestis.

Kuue riigi kogemused

Soomes on juba pikemat aega lähtunud põhimõttest, et pikaajalist hooldust vajav inimene peab saama kodus elada nii kaua kui võimalik. Koduhoolduse ja -õenduse toel saavad kodus elada ka väga suure hooldusvajadusega inimesed. Kuna vajadus teenuste järele aina kasvab, siis teevad nii avalik sektor kui ka eraettevõtjad tihedat koostööd IKT firmadega. Kasutatakse nt veebikaameraid, lairibaihendust ja videotelefone. IKT lahenduste suurim kasutegur ilmneb hoolduskulude säästus. Kuna koduvisiite on vähem, on spetsialistide ajakasutus parem, ka teave hooldatava tervisliku seisundi kohta liigub arstide ja õdede ning koduhooldajate vahel kiiremini. (Perälä 2017).

Kanada kohta koostatud ülevaates (Canadian Home Care Association 2015) tuuakse välja, et IKT lahenduste kasutuselevõtt on parandanud koduhooldusmeeskonna liikmete suhtlust. Valdkondade vahel digitaalset informatsiooni vahetades tuleb järgida samu standardeid ja terminoloogiat. Nutiseadmete abil korraldatud videokonverents laseb klienti/patsienti ja hooldusmeeskonda nõustada reaalajas, seda tehes tuginetakse inimese tervisliku seisundi jälgimise andmetele. Liikumis-, kukkumis- jm andurid aitavad edastata lähedastele ja hooldajatele infot üksi elava eaka olukorra kohta. Telemonitooringu kasutamine koduhoolduses parandab ravi ja hoolduse tõhusust ja vähendab ravikulusid. Eriti tähtis on see nt hajaasustusega maapiirkondades, kus teenusekasutajateni jõudmiseks tuleb läbida pikki vahemaid.

Suurbritannia koduhoolduses on olulised personaalsus ja inimese heaolu. Koduhooldust puudutavad strateegilised dokumendid käsitlevad eelkõige hooldatavaid, hooldajaid jt spetsialiste, üsna vähe aga kasutatavat tehnoloogiat. IKT-põhiseid lahendusi on mitmes piirkonnas küll edukalt katsetatud, kuid suur osa infost on alles paberil. Samas muudaks IKT võimaluste laiem kasutus hooldusega seotud avaliku sektori ja eraettevõtete tegevuse läbipaistvamaks. Ka Ühendkuningriigis rõhutatatakse standardite väljatöötamise vajadust, sest siis oleks vajalik info kättesaadav ja see hõlbustaks adekvaatsete otsuste tegemist (Homecare UK s. a).

Iirimaa töötab 2019. aastaks koos Belgia ja Itaaliaga elluviidava Euroopa Liidu projekti ProACT raames välja koduhooldusmudeli kroonilisi haigusi põdevate eakate jaoks (Homeinstead

2016). Kaasatud on koostööpartnerid koduhooldusest, tööstusest (IBM, Philips jt) ja teadusasutused. Eesmärk on, et kroonilisi haigusi (diabeeti, südameveresoonekonna- ja kopsuhaigusi jt) põdevad eakad saaksid abistavat tehnoloogiat kasutades võimalikult kaua elada oma kodus. Projekti raames arendatakse välja liidesed, mis seostavad koduhoolduse uued tehnoloogilised lahendused (sensorid jt) integreeritud tervishoiusüsteemidega. Uue koduhooldustöö mudeli puhul taotletakse patsiendikesksust: IKT võimalusi kasutatakse informatsiooni efektiivseks jagamiseks, arvestades samas kõigi hooldustöö aspektidega.

Uus-Meremaal panustatakse palju IKT uuendustesse, et välja kujundada igast inimesest lähtuv abi (ICT Homecare New Zealand 2017). Arendusel olevad IKT süsteemid (nt IBM Watson) võimaldavad edastada reaalajas inimese terviseandmed, mille põhjal saab inimesele pakutavaid abimeetmeid pidevalt kohaldada (reprogrammeerida). Telekommunikatsiooni vahenditega informatsiooni edastades saab inimene ka ise parema ülevaate oma tervislikust seisundist. Suurt tähelepanu pööratakse terviseandmete turvalisele säilitamisele ja konfidentsiaalsusele.

Jaapanis on tehnoloogia kiire areng võimaldanud oluliselt parandada koduhooldust (Kamei 2013). IKT kasutamisse koduhoolduses panustavad lisaks riigile ka teadusasutused ja eraettevõtted. Seda saab rakendada abivajadusi klassifitseerides, andmeid kogudes, turu-uuringuid tehes, hooldust vajavate inimeste tervislikku seisundit jälgides ja selle muutustele reageerides.

Arvestades eakate arvu kasvu ja robootika arengut Jaapanis, on seal aktuaalseks muutunud robotite kasutamine koduhoolduses ja -rehabilitatsioonis.

Kokkuvõte

Kroonilisi haigusi (sh kopsu-, südame ja veresoonkonna haigusi, diabeeti, vähki, insulti, seljaaju kahjustusi) põdevate inimeste toetamisel kasutatakse koduhoolduses kõige rohkem videotehnoloogiaid (videotelefone, videokonverentse), tekstisõnumeid ja tervisliku seisundi jälgimist või nende kombinatsiooni. Tehnoloogia aitab teenusekasutajatel ja nende lähedastel hooldustöötajatega suhelda, vajadusel saab kiiresti spetsialisti konsultatsiooni ja emotsionaalset tuge. Tervisliku seisundi jälgimine lasneb kõiki andmeid koguda reaalajas ning ruttu ja õigesti muutustele reageerida.

IKT lahendustega toetatud koduhooldus vähendab haiglas ja/või hooldusraviasutuses oldud aega ning võimaldab paremini hinnata erivajadusest tingitud abivahendite ning sotsiaalsete teenuste asjakohasust. Kaugteel saadud infot saab kasutada diagnoosides ja ravi määraates, video teel on võimalik anda erialast konsultatsiooni. IKT lahendusi saab edukalt kasutada eri sihtrühmade hoolduses, nt abi vajavad või liikumispuudega eakad, dementsuse eri vormidega ja kroonilisi haigusi põdevad eakad, liikumis- või intellektipuudega nooremad abivajajad (Lindberg jt 2013).

Väga oluline on ka kõigi asjaosaliste (teenusekasutaja, tema lähedased, koduõde, hooldustöötaja, sotsiaaltöötaja, arst jt) suhtlusvõimaluste parandamine. Kui

Eestis ei toimi koduhooldajad, -õed jt inimest kodus külastavad spetsialistid sageli kooskõlastatult (Paat-Ahi 2017, 17–20), siis teistes riikides peetakse tähtsaks, et spetsialistid tegutseksid ühtse meeskonnana ja üldjuhul on koordineerijaks koduõde.

Kuidas toimida Eestis?

Eestis on IKT lahendusi seni katsetatud üksikutes projektides (nt VIRTU suhtlus- ja nõustamiskeskond eakatele, kroonilise haigusega eakate kodujälgimisprojekt SmartCare), kõige pikemad kogemused on meil häirenuputeenusega.

Võib ennustada, et tulevikus on IKT lahendustel ka pikaajalises hoolduses järjest suurem roll ning seda valdkonda tuleks hakata arendama läbimõeldult. Kindlasti on vaja kokku leppida ka kasutatavates mõistetes, et kõik asjaosalised saaksid ühtmoodi aru, mida me mõtleme, kui kasutame sõnu e-tervis, teleditsiin, telehooldus jms.

Riigi, erasektori ja tehnoloogiafirmade koostöös on tarvis arendada suhtlemist hõlbustavaid ja kiiret konsulteerimist võimaldavaid lahendusi.

IKT seadmed ja abivahendid peaksid olema kohandatud vastavaks iga inimese vajadustega, olema osa individuaalsest hoolduskavast. Kui IKT lahenduste kasutus laieneb, siis tuleb neile kehtestada ka standardid, et muu hulgas oleks tagatud inimese konfidentsiaalsus, privaatsus jm õigused.

Eesmärk on abistatava optimaalne elukvaliteet olemasolevate võimaluste piires. Pikaajalisi hooldusteenuseid tuleb pakkuda kooskõlastatult ja meilgi võiks meeskonna koordineerija olla koduõde. **S**

Viidatud allikad

- Canadian Home Care Association** on the issues-ICT (2015), www.cdnhomework.ca (22.11.2018).
- ICT Homecare New Zealand** (2017). www.homecaremedical.co.nz/ (22.11.2018).
- Homecare UK** (s. a). *Homecare Reviews & Nursing Agencies Reviews*. <https://homecare.co.uk> (22.11.2018).
- Homeinstead.ie** (2016). ProAct-Major EU Research Project. www.homeinstead.ie/news-events/2016/06/08/new-cutting-edge-health-technology-to-enable-older-people-with-chronic-illnesses-to-be-treated-in-their-own-homes-launched-by-new-minister-of-state-for-older-people (22.11.2018).
- Kamei, T.** (2013). Information and Communication technology for homecare in future. *Journal of Nursing Science* 10, 154–161.
- Lindberg, B., Nilsson, C., Zotterman, D., Söderberg, S., Skär, L.** (2013). Using Information and Communication Technology in Home Care for Communication between Patients Family Members, Health care Professionals: Systematic Review. *International Journal of Telemedicine and Applications*, vol. 2013.
- Paat-Ahi, G.** (2017) Pikaajalise hoolduse praegused probleemid ja võimalikud lahendused. *Sotsiaaltöö* 4, 17–19.
- Perälä, S.** (2017). Technology in elderly care. Finland. Ettekanne hoolekande ja tervishoiu IKT konverentsil Medixine, Helsinki.
- Tarum, H.** (2017). Hoolduskoormuse vähendamise esmased abinõud. *Sotsiaaltöö* 4, 15–17;
- The World Bank Group.** (2017). Reducing the burden of care in Estonia. <https://riigikantselei.ee/et/hoolduskoormus>. (22.11.2018).